



Nuansa
Fajar
Cemerlang

PELAYANAN ANTENATAL TERPADU DENGAN PRAKTEK KONSELING MENYUSUI MENINGKATKAN KEBERHASILAN MENYUSUI EKSKLUSIF

Sudarmi • lin Rumintang

Ni Putu Dian Ayu Anggraeni • Halimatussyaadiah

**PELAYANAN ANTENATAL TERPADU DENGAN
PRAKTEK KONSELING MENYUSUI
MENINGKATKAN KEBERHASILAN MENYUSUI
EKSKLUSIF**

Dr. Sudarmi, SST., M.Biomed.

Bq. Iin Rumintang, SST., M.Keb.

Ni Putu Dian Ayu Anggraeni, SST., M.Tr.Keb.

St. Halimatussyaadiah, SST., M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**Pelayanan Antenatal Terpadu dengan Praktek Konseling Menyusui
Meningkatkan Keberhasilan Menyusui Eksklusif**

Penulis: Dr. Sudarmi.,SST.M.Biomed

Bq. Iin Rumintang.,SST.M.Keb

Ni Putu Dian Ayu Anggraeni.,SST. .M.Tr.Keb

St. Halimatussyaadiah., SST.M.Kes

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7097-58-3

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2024

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Pelayanan antenatal terpadu dengan praktek konseling menyusui meningkatkan keberhasilan menyusui eksklusif / Dr. Sudarmi., S.S.T., M.Biomed., Bq. Iin Rumintang., S.S.T., M.Keb., Ni Putu Dian Ayu Anggraeni., S.S.T., M.Tr.Keb., St. Halimatussyaadiah., S.S.T., M.Kes.

EDISI

Cetakan pertama, 2024

PUBLIKASI

Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2024.

DESKRIPSI FISIK

iv, 68 halaman : ilustrasi ; 30 cm

IDENTIFIKASI

ISBN 978-634-7097-58-3

SUBJEK

Laktasi

KLASIFIKASI

612.664 [23]

PERPUSNAS ID

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1076464>

PRAKATA

Konseling menyusui selama ANC dapat mendorong pemberian ASI dini, namun konseling tidak umum dilakukan. Walaupun cakupan K1-dan K4 melampaui target namun hanya seperlima bidan melakukan pelayanan ANC secara lengkap dan benar untuk komponen pelayanan 10 T. Antenatal terpadu dengan praktek konseling menyusui akan lebih bermanfaat dan mudah dipahami oleh ibu hamil sehingga nantinya dapat meningkatkan cakupan ASI eksklusif untuk menurunkan angka stunting.

Keberhasilan pemberian ASI eksklusif sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan ibu, dukungan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi. Meningkatkan kesadaran akan manfaat ASI eksklusif serta menyediakan dukungan yang memadai bagi ibu adalah langkah penting untuk mencapai target cakupan yang lebih tinggi di masa depan.

Peningkatan pengetahuan dan dukungan emosional, dapat dilakukan melalui konseling dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi ibu dalam proses menyusui, sehingga mendukung kesehatan bayi dan ibu secara keseluruhan. Konseling menyusui merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan angka pemberian ASI eksklusif di kalangan ibu-ibu baru. Konseling tidak hanya memberikan informasi tetapi juga dukungan emosional kepada ibu, yang dapat mengurangi stres dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menyusui. Ini penting karena banyak ibu merasa khawatir tentang volume ASI yang mereka hasilkan, terutama pada minggu-minggu awal setelah melahirkan.

Didalam buku ini membahas tentang pentingnya pelaksanaan antenatal care terpadu praktek konseling menyusui. Bila ibu hamil sudah berikan motivasi sejak masa

kehamilan, maka ibu akan termotivasi dan pasti Bisa karena pada saat pelaksanaan praktek konseling, ibu Bidan langsung mempraktekkan dan mendemonstrasikan tehnik menyusui. Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil dengan baik dan dapat menerapkan dalam melaksanakan antenatal care terpadu dengan konseling menyusui.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan, Kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan buku ini.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI	v
-------------------------	----------

BAB 1 PENDAHULUAN.....	7
-------------------------------	----------

BAB 2 PELAYANAN ANTENATAL TERPADU.....	1
---	----------

A. Pengertian Pelayanan Antenatal Terpadu	1
B. Indikator	2
C. Langkah Teknis Pelayanan Antenatal Terpadu	5
D. Pelayanan Antenatal Terpadu.....	9

BAB 3 ASI EKSKLUSIF	25
----------------------------------	-----------

A. Definisi.....	25
B. Manfaat.....	26
C. Pemberian Air Susu Ibu	28
D. Inisiasi Menyusu Dini.....	31
E. Cara Menyusui	32

BAB 4 KELAS ANTENATAL TERPADU KONSELING MENYUSUI.....	38
A. Pelaksanaan Kelas Antenatal terpadu Konseling Menyusui.....	38
B. Pendidikan Kesehatan Meningkatkan Keberhasilan ASI eksklusif	41
C. Kegiatan Dukungan Pada Antenatal	42
D. Konseling Antenatal.....	50
 BAB 5 PENUTUP	 56
 DAFTAR PUSTAKA.....	 58
 GLOSARIUM	 62
 PROFIL PENULIS.....	 64

BAB 1

PENDAHULUAN

ASI eksklusif, yaitu pemberian air susu ibu (ASI) tanpa tambahan makanan atau minuman lain kepada bayi berusia 0-6 bulan, memiliki banyak manfaat yang signifikan bagi kesehatan bayi dan ibu. Keberhasilan dalam pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun manfaatnya jelas, cakupan pemberian ASI eksklusif masih rendah [1]. Data menunjukkan bahwa cakupan global hanya mencapai 38%, dengan negara berkembang seperti Indonesia memiliki rata-rata antara 47% hingga 57% [2]. Pada tahun 2020, Indonesia mencatatkan angka capaian sebesar 66,1%, meningkat dari tahun sebelumnya tetapi masih di bawah target nasional yang ditetapkan oleh WHO sebesar 80%[3]

Keberhasilan pemberian ASI eksklusif sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan ibu, dukungan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi. Meningkatkan kesadaran akan manfaat ASI eksklusif serta menyediakan dukungan yang memadai bagi ibu adalah langkah penting untuk mencapai target cakupan yang lebih tinggi di masa depan[4].

Peningkatan pengetahuan dan dukungan emosional, dapat dilakukan melalui konseling dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi ibu dalam proses menyusui, sehingga mendukung kesehatan bayi dan ibu secara keseluruhan. Konseling menyusui merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan angka pemberian ASI eksklusif di kalangan ibu-ibu baru (Kebidanan Vokasional et al., n.d.). Konseling tidak

hanya memberikan informasi tetapi juga dukungan emosional kepada ibu, yang dapat mengurangi stres dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menyusui. Ini penting karena banyak ibu merasa khawatir tentang volume ASI yang mereka hasilkan, terutama pada minggu-minggu awal setelah melahirkan[6].

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa konseling yang dilakukan baik selama kehamilan (antenatal) maupun setelah melahirkan (postnatal) lebih efektif dibandingkan hanya satu periode saja. Penggunaan materi edukasi seperti booklet dalam konseling juga berkontribusi pada peningkatan pengetahuan ibu mengenai manajemen laktasi[7]

Beberapa penelitian menyatakan bahwa konseling laktasi efektif diberikan pada masa prenatal, namun hal ini sulit diaplikasikan oleh bidan pada saat ibu hamil melakukan ANC dengan berbagai alasan, seperti banyaknya sasaran, waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan konseling, maka salah satu caranya yaitu dengan membentuk kelas ibu hamil. Adanya program kelas ibu hamil ini telah mampu meningkatkan cakupan kunjungan persalinan di tenaga kesehatan, namun belum mampu meningkatkan cakupan ASI eksklusif, karena pada kelas ibu hamil ini hanya memberikan materi tentang IMD dan ASI eksklusif saja[8]

Pelayanan konseling menyusui yang dilakukan selama antenatal terpadu memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil mengenai menyusui. Konseling menyusui adalah bagian dari pelayanan antenatal terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi dan dukungan kepada ibu hamil mengenai teknik menyusui, manfaat ASI, serta cara mengatasi masalah yang mungkin timbul selama menyusui [9]. Pelayanan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan mencakup berbagai

aspek kesehatan ibu dan bayi. Ibu hamil yang mendapatkan konseling cenderung memiliki pengetahuan lebih baik tentang manfaat ASI dan teknik menyusui yang benar dan kesiapan fisik dan mental untuk menyusui setelah melahirkan, yang berkontribusi pada keberhasilan menyusui [10]

BAB 2

PELAYANAN ANTENATAL TERPADU

A. Pengertian Pelayanan Antenatal Terpadu

Pelayanan antenatal setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan yang komprehensif dan berkualitas dan diberikan kepada seluruh ibu hamil sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan pengalaman yang bersifat positif serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.

Tujuan pelayanan antenatal terpadu meliputi: 1). Terlaksananya pelayanan antenatal terpadu, termasuk konseling, dan gizi ibu hamil, konseling KB dan pemberian ASI. 2). Terlaksananya dukungan emosi dan psikososial sesuai dengan keadaan ibu hamil pada setiap kontak dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan dan interpersonal yang baik. 3). Setiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu minimal 6 kali selama masa kehamilan. 4). Terlaksananya pemantauan tumbuh kembang janin. 5). Deteksi secara dini kelainan/penyakit/gangguan yang diderita ibu hamil. 6). Dilaksanakannya tatalaksana terhadap kelainan/penyakit/gangguan pada ibu hamil sedini mungkin atau rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang ada[11] .

B. Indikator

1. Kunjungan pertama (K1)

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan dan interpersonal yang baik, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama, sebaiknya sebelum minggu ke 8. Kontak pertama dapat dibagi menjadi K1 murni dan K1 akses.

K1 murni adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan pada kurun waktu trimester 1 kehamilan. Sedangkan K1 akses adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan pada usia kehamilan berapapun. Ibu hamil seharusnya melakukan K1 murni, sehingga apabila terdapat komplikasi atau faktor risiko dapat ditemukan dan ditangani sedini mungkin.

2. Kunjungan ke-4 (K4)

K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu dan komprehensif sesuai standar selama kehamilannya minimal 4 kali dengan distribusi waktu: 1 kali pada trimester pertama (0-12 minggu), 1 kali pada trimester kedua (>12minggu -24 minggu), dan 2 kali pada trimester ketiga (>24 minggu sampai dengan kelahiran). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan (jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan).

3. Kunjungan ke-6 (K6)

K6 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu dan

komprehensif sesuai standar selama kehamilannya minimal 6 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu: 2 kali pada trimester kesatu (0-12 minggu), 1 kali pada trimester kedua (>12minggu - 24 minggu), dan 3 kali pada trimester

ketiga (>24 minggu sampai dengan kelahiran), dimana minimal 2 kali ibu hamil harus kontak dengan dokter (1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester 3). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 6 (enam) kali sesuai kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan. Jika kehamilan sudah mencapai 40 minggu, maka harus dirujuk untuk diputuskan terminasi kehamilannya. Pemeriksaan dokter pada ibu hamil dilakukan saat:

- a. Kunjungan 1 di trimester 1 (satu) dengan usia kehamilan kurang dari 12 minggu atau dari kontak pertama. Dokter melakukan skrining kemungkinan adanya faktor risiko kehamilan atau penyakit penyerta pada ibu hamil termasuk didalamnya pemeriksaan Ultrasonografi (USG). Apabila saat K1 ibu hamil datang ke bidan, maka bidan tetap melakukan ANC sesuai standar, kemudian merujuk ke dokter.
- b. Kunjungan 5 di trimester 3. Dokter melakukan perencanaan persalinan, skrining faktor risiko persalinan termasuk pemeriksaan Ultrasonografi (USG) dan rujukan terencana bila diperlukan.

Standar pelayanan antenatal terpadu minimal adalah sebagai berikut (10T):

1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
2. Ukur tekanan darah
3. Nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas/LILA)
4. Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri)

5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
6. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan
7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan
8. Tes laboratorium: tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B) dan malaria pada daerah endemis. Tes lainnya dapat dilakukan sesuai indikasi seperti: glukoprotein urin, gula darah sewaktu, sputum Basil Tahan Asam (BTA), kusta, malaria daerah non endemis, pemeriksaan feses untuk kecacingan, pemeriksaan darah lengkap untuk deteksi dini thalasemia dan pemeriksaan lainnya.
9. Tata laksana/penanganan kasus sesuai kewenangan
10. Temu wicara (konseling) Informasi yang disampaikan saat konseling minimal meliputi hasil pemeriksaan, perawatan sesuai usia kehamilan dan usia ibu, gizi ibu hamil, kesiapan mental, mengenali tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, persiapan persalinan, kontrasepsi pascapersalinan, perawatan bayi baru lahir, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif.

Keterangan:

1. Tes laboratorium yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal adalah: pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan Hb dan pemeriksaan glukoproteinuri (atas indikasi).
2. Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki vaksin tetanus difteri dan/atau pemeriksaan laboratorium, fasilitas pelayanan kesehatan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk penyediaan dan/atau pemeriksaan, atau merujuk ibu hamil ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang dapat melakukan pemeriksaan tersebut.

C. Langkah Teknis Pelayanan Antenatal Terpadu

1. Menyediakan kesempatan pengalaman positif bagi setiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu pada saat dibutuhkan.

Pelayanan antenatal terpadu diberikan pada saat petugas kesehatan kontak dengan ibu hamil. Kontak dalam hal ini didefinisikan sebagai saat petugas kesehatan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan maupun saat di dalam sebuah komunitas/lingkungan. Kontak sebaiknya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga ibu hamil mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan komprehensif.

2. Layanan ANC oleh dokter umum

Ibu hamil minimal 2x diperiksa oleh dokter, 1x pada trimester 1 dan 1x pada trimester 3 (kunjungan antenatal ke 5).

a. Kunjungan pada trimester 1

Pemeriksaan dokter pada kontak pertama ibu hamil di trimester 1 bertujuan untuk skrining adanya faktor risiko atau komplikasi. Apabila kondisi ibu hamil normal, kunjungan antenatal dapat dilanjutkan oleh bidan. Namun bilamana ada faktor risiko atau komplikasi maka pemeriksaan kehamilan selanjutnya harus ke dokter atau dokter spesialis sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter tetap mengikuti pola anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan tindak lanjut:

- 1) Anamnesis dan Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil
 - a) Anamnesis: kondisi umum, data dasar, HPHT, siklus haid, faktor risiko infeksi saluran reproduksi, dll
 - b) Riwayat Kesehatan ibu sekarang: hipertensi, jantung, asma, TB, tiroid, HIV, IMS, hepatitis B, alergi, asma, autoimun, diabetes, dll.
 - c) Skrining status imunisasi tetanus
 - d) Riwayat perilaku berisiko 1 bulan sebelum hamil: merokok, minum alkohol, minum obat-obatan, pola makan berisiko, aktifitas fisik, pemakaian kosmetik, dll.
 - e) Riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya (termasuk keguguran, hamil kembar dan lahir mati).
 - f) Riwayat penyakit keluarga: hipertensi, diabetes, sesak nafas, asma, jantung, TB, alergi, gangguan kejiwaan, kelainan darah, Hepatitis B, HIV, dll.
- 2) Pemeriksaan Fisik Umum
 - a) Keadaan umum, kesadaran, konjungtiva, sklera, kulit, leher, gigi mulut, THT, jantung, paru, perut, ekstremitas. Berat badan dan tinggi badan
 - b) Tanda vital: tekanan darah, nadi, suhu tubuh, frekuensi nafas
- 3) Pemeriksaan terkait kehamilan
 - a) Lingkar lengan atas
 - b) Pemeriksaan dan penentuan Indeks Masa Tubuh (IMT) sebelum hamil. Skrining preeklamsi (lihat BAB III. Keterpaduan program, sub bab penemuan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular pada Kehamilan).
- 4) Pemeriksaan Penunjang pada kehamilan

- a) Pemeriksaan laboratorium: tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, malaria di daerah endemis, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B), dan tes lainnya sesuai indikasi
- b) Pemeriksaan USG
- c) Pemeriksaan EKG atas indikasi

Pada pemeriksaan pertama oleh dokter, maka dokter harus menyimpulkan status kehamilannya (GPA), kehamilan normal atau kehamilan berkomplikasi (sebutkan jenis komplikasinya). Selain itu dokter harus memberikan rekomendasi antara lain: - ANC dapat dilakukan di FKTP, atau - Konsul ke dokter spesialis, atau Rujuk ke FKRTL. Pada keadaan khusus misalnya wabah penyakit tertentu maka dilakukan skrining awal sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

b. Kunjungan pada trimester 3

Pada kehamilan trimester 3, ibu hamil harus diperiksa dokter minimal sekali (kunjungan antenatal ke-5 dan usia kehamilan 32-36 minggu). Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya faktor risiko pada persalinan dan perencanaan persalinan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter tetap mengikuti pola anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan tindak lanjut:

- 1) Anamnesis dan evaluasi kesehatan ibu hamil Kondisi umum, keluhan Riwayat kesehatan ibu sekarang, status imunisasi tetanus Perencanaan persalinan (tempat persalinan, transportasi, calon pendonor

darah, pembiayaan, pendamping persalinan, dll), Pilihan rencana kontrasepsi, dll.

- 2) Pemeriksaan fisik umum Keadaan umum, kesadaran, konjungtiva, sklera, kulit, leher, gigi mulut, THT, jantung, paru, perut, ekstremitas. -- Berat badan dan tinggi badan. Tanda vital: tekanan darah, nadi, suhu tubuh, frekuensi nafas
- 3) Pemeriksaan terkait kehamilan: Leopold
- 4) Pemeriksaan penunjang pada kehamilan:
 - a) Pemeriksaan penunjang pada kehamilan:
 - b) Pemeriksaan laboratorium: kadar hemoglobin darah, dan pemeriksaan penunjang lain sesuai indikasi pemeriksaan USG.
- 5) Rencana konsultasi lanjut (ke bagian gizi, kebidanan, anak, penyakit dalam, THT, neurologi, psikiatri, dll)
- 6) Konseling
Pada akhir pemeriksaan dokter harus bisa menyimpulkan: Status kehamilannya (GPA) Tidak didapatkan penyulit pada kehamilan saat ini, atau Didapatkan masalah kesehatan/komplikasi (sebutkan)

Dokter juga harus memberikan rekomendasi: Dapat melahirkan di FKTP (PONED/non PONED) Rujuk untuk melahirkan di FKRTL Konsultasi ke dokter spesialis untuk menentukan tempat persalinan

D. Pelayanan Antenatal Terpadu

1. Menyediakan kesempatan pengalaman positif bagi setiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu pada saat dibutuhkan.

Pelayanan antenatal terpadu diberikan pada saat petugas kesehatan kontak dengan ibu hamil. Kontak dalam hal ini didefinisikan sebagai saat petugas kesehatan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan maupun saat di dalam sebuah komunitas/lingkungan. Kontak sebaiknya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga ibu hamil mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan komprehensif.

2. Layanan ANC oleh dokter umum

Ibu hamil minimal 2x diperiksa oleh dokter, 1x pada trimester 1 dan 1x pada trimester 3 (kunjungan antenatal ke 5).

Kunjungan pada trimester 1

Pemeriksaan dokter pada kontak pertama ibu hamil di trimester 1 bertujuan untuk skrining adanya faktor risiko atau komplikasi. Apabila kondisi ibu hamil normal, kunjungan antenatal dapat dilanjutkan oleh bidan. Namun bilamana ada faktor risiko atau komplikasi maka pemeriksaan kehamilan selanjutnya harus ke dokter atau dokter spesialis sesuai dengan kompetensi dan wewenangnyanya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter tetap mengikuti pola anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan tindak lanjut:

- a. Anamnesis dan Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil

- 1) Anamnesis: kondisi umum, data dasar, HPHT, siklus haid, faktor risiko infeksi saluran reproduksi, dll

- 2) Riwayat Kesehatan ibu sekarang: hipertensi, jantung, asma, TB, tiroid, HIV, IMS, hepatitis B, alergi, asma, autoimun, diabetes, dll.
 - 3) Skrining status imunisasi tetanus
 - 4) Riwayat perilaku berisiko 1 bulan sebelum hamil: merokok, minum alcohol, minum obat-obatan, pola makan berisiko, aktifitas fisik, pemakaian kosmetik, dll.
 - 5) Riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya (termasuk keguguran, hamil kembar dan lahir mati).
 - 6) Riwayat penyakit keluarga: hipertensi, diabetes, sesak nafas, asma, jantung, TB, alergi, gangguan kejiwaan, kelainan darah, Hepatitis B, HIV, dll.
- b. Pemeriksaan Fisik Umum
- 1) Keadaan umum, kesadaran, konjungtiva, sklera, kulit, leher, gigi mulut,
 - 2) THT, jantung, paru, perut, ekstremitas.
 - 3) Berat badan dan tinggi badan
 - 4) Tanda vital: tekanan darah, nadi, suhu tubuh, frekuensi nafas
- c. Pemeriksaan terkait Kehamilan
- 1) Lingkaran lengan atas Pemeriksaan dan penentuan Indeks Masa Tubuh (IMT) sebelum hamil.
- d. Pemeriksaan Penunjang Pada Kehamilan
- 1) Pemeriksaan laboratorium: tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, malaria di daerah endemis, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B), dan tes lainnya sesuai indikasi-
 - 2) Pemeriksaan USG
 - 3) Pemeriksaan EKG atas indikasi

Pada pemeriksaan pertama oleh dokter, maka dokter harus menyimpulkan status kehamilannya (GPA), kehamilan normal atau kehamilan berkomplikasi (sebutkan jenis komplikasinya). Selain itu dokter harus memberikan rekomendasi antara lain: - ANC dapat dilakukan di FKTP, atau- Konsul ke dokter spesialis, atau Rujuk ke FKRTL Pada keadaan khusus misalnya wabah penyakit tertentu maka dilakukan skrining awal sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kunjungan pada trimester 3

Pada kehamilan trimester 3, ibu hamil harus diperiksa dokter minimal sekali (kunjungan antenatal ke-5 dan usia kehamilan 32-36 minggu). Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya faktor risiko pada persalinan dan perencanaan persalinan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter tetap mengikuti pola anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan tindak lanjut:

- a. Anamnesis dan evaluasi kesehatan ibu hamil Kondisi umum, keluhan Riwayat kesehatan ibu sekarang, status imunisasi tetanus Perencanaan persalinan (tempat persalinan, transportasi, calon pendonor darah, pembiayaan, pendamping persalinan, dll), Pilihan rencana kontrasepsi, dll.
- b. Pemeriksaan fisik umum Keadaan umum, kesadaran, konjungtiva, sklera, kulit, leher, gigi mulut, THT, jantung, paru, perut, ekstremitas. -- Berat badan dan tinggi badan. Tanda vital: tekanan darah, nadi, suhu tubuh, frekuensi nafas

- c. Pemeriksaan terkait kehamilan: Leopold
 - d. Pemeriksaan penunjang pada kehamilan: Pemeriksaan laboratorium: kadar hemoglobin darah, dan pemeriksaan penunjang lain sesuai indikasi Pemeriksaan USG
 - e. Rencana konsultasi lanjut (ke bagian gizi, kebidanan, anak, penyakit dalam, THT, neurologi, psikiatri, dll)
 - f. Konseling
Pada akhir pemeriksaan dokter harus bisa menyimpulkan: Status kehamilannya (GPA) Tidak didapatkan penyulit pada kehamilan saat ini, atau Didapatkan masalah kesehatan/komplikasi (sebutkan) Dokter juga harus memberikan rekomendasi: Dapat melahirkan di FKTP (PONED/non PONED) Rujuk untuk melahirkan di FKRTL Konsultasi ke dokter spesialis untuk menentukan tempat persalinan.
3. Layanan ANC oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi klinis/kebidanan selain dokter
- Apabila saat kunjungan antenatal dengan dokter tidak ditemukan faktor risiko maupun komplikasi, kunjungan antenatal selanjutnya dapat dilakukan ke tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi klinis/kebidanan selain dokter. Kunjungan antenatal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter adalah kunjungan ke-2 di trimester 1, kunjungan ke-3 di trimester 2 dan kunjungan ke-4 dan 6 di trimester 3. Tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan antenatal, konseling dan memberikan dukungan sosial pada saat kontak dengan ibu hamil. Pemeriksaan antenatal dan konseling yang dilakukan adalah:
- a. Anamnesis:
 - 1) kondisi umum, keluhan saat ini.

- 2) Kondisi umum, keluhan saat ini Tanda-tanda penting yang terkait masalah kehamilan: mual/muntah, demam, sakit kepala, perdarahan, sesak nafas, keputihan, dll
 - 3) Gerakan janin
 - 4) Riwayat kekerasan terhadap perempuan (KtP) selama kehamilan
 - 5) Perencanaan persalinan (tempat persalinan, transportasi, calon pendonor darah, pembiayaan, pendamping persalinan, dll)
 - 6) Pemantauan konsumsi tablet tambah darah
 - 7) Pola makan ibu hamil Pilihan rencana kontrasepsi, dll
- b. Pemeriksaan fisik umum Pemantauan berat badan Pemantauan tanda vital: tekanan darah, nadi, suhu tubuh, frekuensi nafas Pemantauan LiLA pada ibu hamil KEK
 - c. Pemeriksaan terkait kehamilan Pemeriksaan tinggi fundus uteri (TFU) Pemeriksaan Leopold Pemeriksaan denyut jantung janin
 - d. Pemeriksaan penunjang: pemeriksaan hemoglobin darah pada ibu hamil anemi, pemeriksaan glukoproteinuri
 - e. Pemberian imunisasi Td sesuai hasil skrining
 - f. Suplementasi tablet Fe dan kalsium
 - g. Komunikasi, informasi, edukasi dan konseling:
 - 1) Perilaku hidup bersih dan sehat
 - 2) Tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas
 - 3) Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)
 - 4) Peran suami dan keluarga dalam kehamilan dan perencanaan persalinan

- 5) Asupan gizi seimbang KB paska persalinan IMD dan pemberian ASI eksklusif
- 6) Peningkatan kesehatan intelegensia pada kehamilan (Brain Booster)
- 7) Untuk meningkatkan intelegensia bayi yang akan dilahirkan, ibu hamil dianjurkan memberikan stimulasi auditori dan pemenuhan nutrisi pengungkitt otak (brain booster) secara bersamaam pada periode kehamilan.

Tenaga kesehatan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi ibu hamil (menggunakan grafik evaluasi kehamilan dan grafik peningkatan berat badan, terlampir). Apabila hasil pemantauan dan evaluasi melewati garis batas grafik, ibu hamil harus dikonsultasikan ke dokter.

Indikasi merujuk ke dokter dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

- a. Riwayat kehamilan dahulu
 - 1) Riwayat perdarahan pada kehamilan/ persalinan/ nifas
 - 2) Riwayat hipertensi pada kehamilan/nifas
 - 3) Riwayat IUFD/stillbirth
 - 4) Riwayat kehamilan kembar
 - 5) Riwayat keguguran > 3x berturut-turut
 - 6) Riwayat kehamilan sungsang/letak lintang/letak oblik
 - 7) Riwayat kematian janin/perinatal
 - 8) Riwayat persalinan dengan SC, dll
- b. Riwayat medis

- 1) Riwayat penyakit tidak menular (jantung, hipertensi, diabetes mellitus, ginjal, alergi makanan/obat, autoimun, talasemia/gangguan hematologi lain, epilepsi, dll)
- 2) Riwayat penyakit menular (HIV, Sifilis/IMS lainnya, Hepatitis B, TB, malaria, tifoid, dll)
- 3) Riwayat masalah kejiwaan, dll
- c. Riwayat kehamilan sekarang
 - 1) Muntah berlebihan sampai tidak bisa makan dan minum
 - 2) Perdarahan
 - 3) Nyeri perut hebat
 - 4) Pusing/sakit kepala berat
 - 5) Demam lebih dari 2 hari
 - 6) Keluar cairan berlebihan dan berbau dari vagina
 - 7) Batuk lama lebih dari 2 minggu atau kontak erat/serumah dengan penderita tuberkolosis
 - 8) Gerakan janin berkurang atau tidak terasa (mulai kehamilan 20 minggu)
 - 9) Perubahan perilaku: gelisah, menarik diri, bicara sendiri, tidak mau mandi
 - 10) Kekerasan fisik
 - 11) Gigi dan mulut: gigi berlubang, gusi mudah berdarah, gusi bengkak, dll

Tabel 1.1 Palpasi Abdomen Dan Teknik Leopold I-Iv [12]

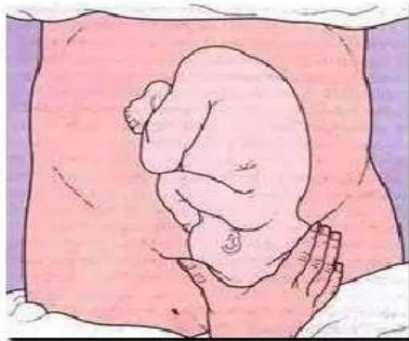
Tehnik	Waktu Pengukuran	Tujuan
Palpasi Abdomen	Awal Trimester I	- Meraba ada/tidak massa intra abdomen - Menentukan tinggi fundud uteri
Pemeriksaan Leopold I  Gambar 1. Palpasi Leopold I -		
- Memposisikan ibu dengan lutut fleksi (kaki ditekuk 45°) atau lutut bagian dalam diganjal atau lutut bagian dalam diganjal bantal) dan	Akhir Trimester I	Untuk menentukan usia kehamilan dan juga untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus

pemeriksa menghadap ke arah ibu. - Menengahkan uterus dengan menggunakan kedua tangan dari arah samping umbilical. - Menengahkan uterus dengan menggunakan kedua tangan dari arah samping umbilical. - Kedua tangan meraba fundus kemudian menentukan TFU - Meraba bagian Fundus dengan menggunakan ujung kedua tangan, tentukan bagian janin.		uteri (bagian atas perut ibu). Hasil: Apabila kepala janin teraba di bagian fundus, yang akan teraba adalah keras, bundar dan melenting (seperti mudah digerakkan) melenting (seperti mudah digerakkan) Apabila bokong janin teraba di bagian fundus, yang akan terasa adalah lunak, kurang bundar, Apabila bokong janin teraba di bagian fundus, yang akan terasa adalah lunak, kurang bundar, dan kurang melenting dan kurang melenting. Apabila posisi janin melintang pada rahim, maka pada Fundus teraba kosong.
--	--	--

Pemeriksaan Leopold II  Gambar 1.2: Palpasi Leopold II		
Posisi ibu masih dengan lutut fleksi (kaki ditekuk) dan pemeriksa menghadap ibu Meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu sejajar dan pada ketinggian yang sama. Mulai dari bagian atas tekan secara bergantian atau bersamaan (simultan)	Trimester II dan III	untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus, pada letak lintang tentukan di mana kepala janin. Hasil: Bagian punggung: akan teraba jelas, rata, cembung, kaku/tidak dapat digerakkan. Bagian-bagian kecil (tangan dan kaki): akan teraba

telapak tangan tangan kiri dan kanan kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang (punggung) atau bagian-bagian kecil (ekstremitas)		kecil, bentuk/posisi tidak jelas menonjol, kemungkinan teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif.
---	--	---

Pemeriksaan Leopold III



Gambar 1.3: Palpasi Leopold III

Posisi ibu masih dengan lutut fleksi (kaki ditekuk) dan pemeriksa menghadap ibu Meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah, telapak		Untuk menentukan bagian janin apa (kepala atau bokong) yang terdapat dibagian bawah perut ibu,
--	--	--

tangan kanan bawah perut ibu. Menekan secara lembut dan bersamaan/bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi Gunakan tangan kanan dengan ibu jari dan keempat jari lainnya kemudian goyang bagian terbawah janin.		Hasil: Bagian keras, bulat dan hampir homogen adalah kepala sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Apabila bagian terbawah janin sudah memasuki PAP, maka saat bagian bawah digoyang, sudah tidak bias (seperti ada tahanan).
--	--	---

Pemeriksaan Leopold IV

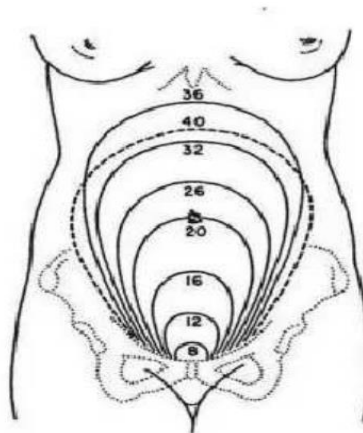


Gambar 1.4: palpasi Leopold 4

Pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu, dengan posisi kaki ibu lurus Meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah, ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan pada tepi atas simfisis Menemukan kedua ibu jari kiri dan kanan kemudian rapatkan semua jari-jari tangan yang meraba dinding bawah uterus. Perhatikan sudut yang terbentuk oleh jari-jari: bertemu (konvergen) atau tidak bertemu (divergen) Setelah itu memindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi (bila presentasi kepala upayakan memegang bagian kepala di dekat leher dan bila presentasi bokong upayakan untuk memegang pinggang bayi)		Untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Hasil: Apabila kedua jari-jari tangan pemeriksa bertemu (konvergen) berarti bagian terendah janin belum memasuki pintu atas panggul, sedangkan apabila kedua tangan pemeriksa membentuk jarak atau tidak bertemu (divergen) maka bagian terendah janin sudah memasuki Pintu Atas Panggul (PAP) Penurunan kepala dinilai dengan: 5/5 (seluruh bagian jari masih meraba
---	--	---

Memfiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas pa		kepala, kepala belum masuk PAP), 1/5 (teraba kepala 1 jari dari lima jari, bagian kepala yang sudah masuk
Memfiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul kemudian meletakkan jari-jari tangan kanan diantara tangan kiri dan simfisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul.		belum masuk PAP), 1/5 (teraba kepala 1 jari dari lima jari, bagian kepala yang sudah masuk 4 bagian), dan seterusnya sampai 0/5 (seluruh kepala sudah masuk PAP)

Menentukan Usia Kehamilan. [13]



**Gambar 1.5. Gambaran Tinggi Fundus Uteri (TFU)
Dikonversikan dengan Usia Kehamilan (UK)**

Keterangan:

- a. Pada usia kehamilan 24 minggu, fundus dapat teraba tepat di pusat
- b. Pada usia kehamilan 28 minggu, fundus dapat teraba 3 jari di atas pusat
- c. Pada usia kehamilan 32 minggu. Fundus dapat teraba di pertengahan antara Prosesus Xipioideus dan pusat.
- d. Pada usia kehamilan 36 minggu, fundus dapat teraba 3 jari di bawah Prosesus Xipioideus
- e. Pada usia kehamilan 40 minggu, fundus dapat teraba di pertengahan antara Prosesus Xipioideus dan pusat. (Lakukan konfirmasi dengan wawancara dengan pasien untuk membedakan dengan usia kehamilan 32 minggu).

BAB 3

ASI EKSKLUSIF

A. Definisi

1. Beberapa definisi terkait dengan ASI eksklusif meliputi:

- a. ASI Eksklusif: ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
- b. Menyusui Eksklusif: Menyusui eksklusif berarti hanya memberikan ASI saja, tidak memberi bayi makanan atau minuman lain, termasuk air putih, di samping menyusui (kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral tetes; ASI perah juga diperbolehkan).

2. Beberapa definisi terkait dengan menyusui meliputi:

- a. Air Susu Ibu (ASI): Cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
- b. Menyusui: Cara yang normal dan sehat untuk memberi makan bayi dengan cara mengisap payudara ibu.
- c. Menyusui predominan: Menyusui predominan berarti memberikan ASI (menyusui, pemberian ASI perah atau ibu susuan) tapi juga memberi sejumlah kecil cairan lain seperti air, teh.
- d. Menyusui penuh: Menyusui penuh berarti menyusui eksklusif atau predominan.

- e. Menyusui parsial atau campuran: Menyusui parsial berarti menyusui bayi ditambah asupan selain ASI, baik itu susu formula, bubur, atau makanan lainnya.
- f. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Tindakan meletakkan bayi kontak kulit-ke-kulit di dada ibu, dalam 1 jam pertama setelah lahir.
- g. Pemberian makanan buatan: Pemberian makanan buatan berarti memberi bayi susu formula, susu hewan, makanan atau minuman lain seperti bubur sereal yang diencerkan, dan sama sekali tidak menyusui.
- h. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP ASI) Tepat Waktu: Memberikan bayi makanan padat, semi-padat atau makanan lunak yang dimulai pada usia 6 bulan.
- i. Menyusui bayi hingga usia 2 tahun atau lebih: Melanjutkan menyusui hingga bayi usia 2 tahun atau lebih [14]

B. Manfaat

Asi eksklusif merupakan nutrisi ideal untuk bayi 0-6 bulan, kaya akan antibodi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu ikatan batin ibu dengan bayi, meningkatkan kecerdasan anak, berat badan bayi ideal, dan dapat mencegah sudden infant death syndrome (SIDS). Menyusui diperkirakan juga dapat menurunkan risiko diabetes, obesitas, dan kanker tertentu [15].

Kelebihan lain dari ASI yaitu sesuai dengan kebutuhan bayi yang mengonsumsinya. Dengan memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan, membantu perkembangan otak dan menstabilkan tumbuh kembang bayi. Perkembangan kognitif anak yang mengonsumsi ASI lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengonsumsi ASI [16].

ASI merupakan hasil produksi hormon prolactine dan oxytocin yang mengandung banyak immunoglobulin IgA yang baik untuk pertahanan tubuh untuk melawan penyakit. Kandungan dalam ASI yang lengkap mampu mencegah penyakit fisik akut seperti penyakit gastrointestinal, otitis media dan entero nekrotikans neonatal kolitis juga bisa mencegah dari penyakit kronis seperti asma, alergi, dan obesitas dan bagi ibu dapat bermanfaat sebagai kontrasepsi alamiah. Hisapan bayi pada puting susu ibu akan merangsang ujung saraf sensoris di sekitar payudara, rangsangan ini kemudian akan disampaikan ke otak dan merangsang hipofisis anterior untuk memproduksi hormon prolactin agar dapat merangsang sel-sel alveoli [17].

Pemberian ASI eksklusif dapat mencegah stunting. Pemberian ASI eksklusif menurut Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) merekomendasikan aturan menyusui adalah sebagai berikut: inisiasi menyusui dalam satu jam pertama setelah melahirkan, ASI eksklusif selama enam bulan pertama, dan terus menyusui selama dua tahun dengan makanan pendamping yang dimulai pada bulan keenam [18].

Penting bagi kita semua untuk memahami manfaat ASI dan menyusui. Manfaat ASI bagi bayi adalah:

1. Mengandung nutrisi lengkap yang dibutuhkan oleh bayi
2. Mudah dicerna dan digunakan secara efisien oleh tubuh bayi
3. Melindungi bayi dari infeksi
4. Memberikan perlindungan jangka Panjang terhadap penyakit tidak menular kronis (seperti obesitas, hipertensi dan diabetes).
5. Biayanya lebih murah daripada makanan buatan.

Sedangkan manfaat menyusui adalah:

1. Membantu ibu dan bayi untuk bonding (menjalin ikatan yang dekat dan penuh kasih sayang).
2. Membantu perkembangan bayi
3. Melindungi Kesehatan ibu
4. Membantu Rahim Kembali ke ukuran semula sehingga mengurangi perdarahan serta mencegah anemia.
5. Mengurangi risiko kanker ovarium dan kanker payudara pada ibu.
6. Membantu menunda kehamilan baru.

Selain itu, menyusui mempunyai manfaat psikologis yang penting bagi ibu dan bayi.

1. Saling bersentuhan setelah lahir membantu terjalinnya ikatan batin antara ibu dan bayi, dan ibu merasa puas secara emosional.
2. Bayi cenderung lebih jarang menangis jika disusui
3. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menyusui dapat membantu perkembangan intelektual anak. Bayi Berat badan Lahir Rendah (BBLR) yang diberi ASI pada minggu-minggu pertama kehidupannya memiliki kinerja yang lebih baik dalam tes kecerdasan di masa kanak-kanak di kemudian hari dibandingkan anak-anak yang diberi makanan buatan.
4. Jika ibu memutuskan untuk tidak menyusui, penting untuk membantu mereka menjalin ikatan batin dengan bayinya dengan cara lain selain menyusui [19].

C. Pemberian Air Susu Ibu

Praktik pemberian ASI dianjurkan sejak bayi lahir hingga anak berusia 24 bulan atau lebih. Praktik tersebut

dimulai dari Inisiasi Menyusu Dini (IMD), yaitu proses menyusui dimulai segera setelah lahir dilakukan dengan cara kontak kulit dengan kulit antara bayi dan ibu yang berlangsung selama minimal 1 jam, dilanjutkan dengan ASI eksklusif yaitu memberikan hanya ASI saja sejak bayi lahir sampai usia 6 bulan. Bayi disusui sesering mungkin siang dan malam. Sejak usia 6 bulan mulai berikan makanan pendamping ASI (MP ASI) dan ASI diteruskan sampai anak berusia 24 bulan atau lebih [20].

Pemberian ASI eksklusif memberikan banyak manfaat bagi bayi, ibu dan keluarga. Memberikan bayi ASI dapat menciptakan generasi yang mempunyai intelegensi tinggi serta tingkat emosi dan spiritual yang baik dibandingkan dengan bayi yang diberikan susu formula. Selain itu, memberikan ASI eksklusif dapat mempererat ikatan (bonding) antara ibu dan bayi dan meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. Pemberian ASI pada bayi juga jauh lebih mudah, praktis dan ekonomis dibandingkan dengan memberikan susu formula yang lebih mahal dan membutuhkan waktu dalam penyajian. ASI mengandung kolostrum yang dapat membunuh kuman yang ada di dalam tubuh bayi dan sebagai daya tahan tubuh bagi bayi sehingga dapat mengurangi risiko kematian bayi [21]

Dukungan bidan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ASI eksklusif. Ibu yang mendapatkan dukungan bidan dengan baik menjadi lebih percaya diri untuk terus memberikan ASI secara eksklusif. Peran bidan dalam mensosialisasikan pemberian ASI Eksklusif dapat dimulai sejak ibu hamil. Ketika ibu hamil memeriksakan kehamilannya, ibu hamil akan mendapatkan informasi mengenai keuntungan memberikan ASI dan

bagaimana cara sukses menyusui ketika kelahiran bayinya nanti [22].

D. Inisiasi Menyusu Dini

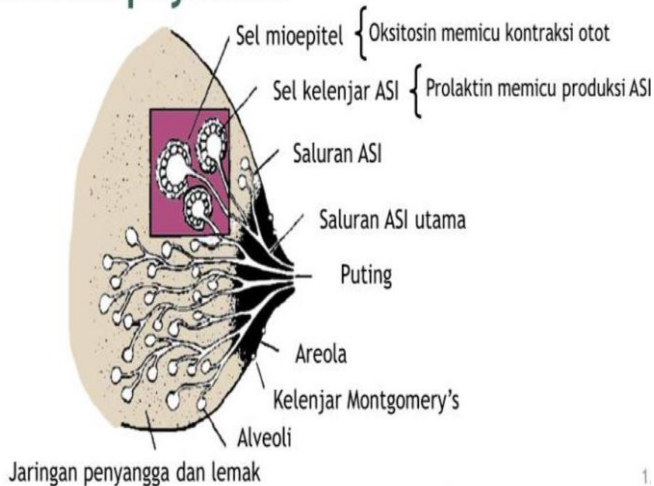
IMD merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif, tetapi bukan satu-satunya faktor, karena terdapat beberapa faktor lain yang juga memengaruhi ASI eksklusif. Untuk itu, diperlukan upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas IMD untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif, tanpa mengabaikan faktor-faktor lainnya [23]. Sebagian besar penelitian ini menemukan bahwa ibu yang melahirkan melalui normal (pervaginam) memiliki tingkat menyusui yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menjalani operasi caesar, dipengaruhi oleh inisiasi menyusui, keluar dari rumah sakit, satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan pascapersalinan. Keberhasilan menyusui eksklusif dipengaruhi oleh Inisiasi Menyusu Dini [24].

Inisiasi menyusui dini (IMD) adalah memberikan ASI segera setelah bayi dilahirkan, biasanya dalam waktu 30 menit sampai dengan 1 jam setelah bayi dilahirkan. Bayi diberi kesempatan untuk memulai atau inisiasi menyusui sendiri segera setelah dilahirkan dengan membiarkan sentuhan atau kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusui pertama selesai. Proses inisiasi menyusui dini ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif yang nantinya akan menekan angka kematian bayi pada usia kurang dari 28 hari (neonatal). Faktor yang menyebabkan IMD dapat menyelamatkan jiwa bayi selain kolostrum (*the gift of life*), yaitu *skin-to-skin* ibu dan bayi yang akan memberikan kehangatan dan perlindungan pada bayi [25].

E. Cara Menyusui

1. Anatomi payudara dan cara payudara memproduksi ASI.

Anatomi payudara



Gambar 3.1 Anatomi Payudara

- Di bagian luar ada areola, yaitu kulit yang berwarna gelap di sekeliling dekat puting. Pada areola ada kelenjar-kelenjar kecil yang disebut kelenjar Montgomery, yang mengeluarkan cairan yang berminyak untuk membersihkan dan melumasi puting.
- Produksi ASI: Ketika bayi menyusui, payudara mengirimkan rangsangan ke otak. Otak kemudian bereaksi mengeluarkan hormon prolaktin yang masuk ke dalam aliran darah menuju kembali ke payudara. Hormon prolaktin merangsang sel-sel pembuat air susu untuk bekerja dan memproduksi susu. Sel-sel pembuat air susu sesungguhnya tidak langsung

bekerja ketika bayi menyusui. Sebagian besar hormon prolaktin berada dalam darah selama kurang lebih 30 menit, setelah proses menyusui. Jadi setelah proses menyusui selesai, barulah sebagian besar hormon prolaktin sampai di payudara dan merangsang sel-sel pembuat air susu untuk bekerja. Jadi, hormon prolaktin bekerja untuk produksi susu berikutnya. Air susu yang diisap bayi saat ini, sudah tersedia dalam payudara, yaitu di pembuluh/saluran air susu.

- c. Mengisap dan memerah ASI sangat penting bagi penyediaan ASI yang baik. Semakin sering diisap bayi, semakin banyak ASI yang diproduksi.
- d. Bila bayi tidak menyusui, ASI yang diproduksi dalam payudara akan lebih sedikit karena ASI yang menetap/"diam" dalam pembuluh/saluran air susu menghambat produksi ASI. Semakin jarang bayi menyusui, semakin sedikit ASI yang diproduksi. Jika bayi berhenti menyusui, payudara juga akan berhenti memproduksi ASI.
- e. Kebanyakan ibu dapat menghasilkan ASI lebih dari yang dibutuhkan bayi mereka. Bila seorang ibu mempunyai bayi kembar dan keduanya menyusui, payudara ibu akan membuat ASI untuk dua bayi. Sebagian besar ibu dapat menghasilkan ASI yang cukup setidaknya untuk dua bayi.
- f. Keluarnya ASI: Ketika menerima rangsangan dari payudara, otak juga mengeluarkan hormon oksitosin selain hormon prolaktin. Hormon oksitosin diproduksi lebih cepat daripada prolaktin. Hormon ini juga masuk ke dalam aliran darah menuju payudara. Di payudara,

hormon oksitosin ini merangsang sel-sel otot untuk berkontraksi. Kontraksi ini menyebabkan ASI hasil produksi sel-sel pembuat susu terdorong mengalir melalui saluran ASI menuju puting. Kadang-kadang, bahkan ASI mengalir hingga keluar payudara ketika bayi sedang tidak menyusui.

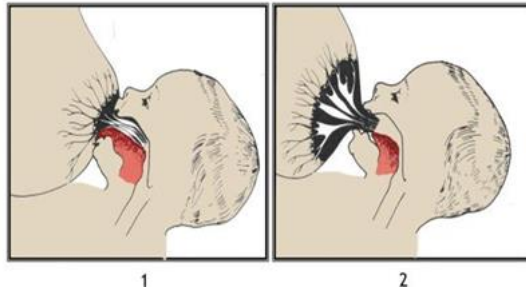
- g. Pelepasan/mengalirnya ASI (kadang disebut refleks ejeksi) dapat dipengaruhi oleh emosi ibu ketakutan, kecemasan, rasa sakit, rasa rindu, dan malu.
- h. ASI awal adalah ASI yang mengandung lebih banyak air dan memuaskan dahaga ibu. ASI akhir mengandung lebih banyak lemak dan menghilangkan rasa lapar bayi.

2. Posisi dan pelekatan yang baik empat ciri posisi menyusui yang baik:

- a. Kepala dan badan bayi membentuk garis lurus
- b. Wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting
- c. Badan bayi dekat ke tubuh ibu
- d. Ibu menggendong/mendekap badan bayi secara utuh[26]

Ketika bayi melekat dengan baik, ASI akan dengan mudah dikeluarkan dan dipindahkan, ini disebut menyusui dengan efektif. Kita dapat melihat dan mendengar bayi menelan ASI saat menyusui dengan efektif. Berikut Gambar bayi melekat dengan baik.

Apa yang bisa kita amati?



Gambar 3.2. Pelekatan yang baik dan tidak baik

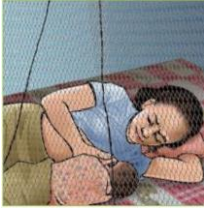
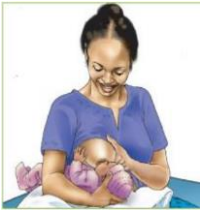
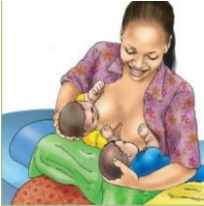
Gambar 1 adalah bayi melekat dengan baik ke payudara; Gambar 2 menunjukkan bayi menyusui dengan cara berbeda (mulut bayi).

Perbedaan terpenting pada gambar 2 adalah:

- a. Hanya puting susu yang ada di mulut bayi, bukan jaringan payudara di balik areola;
- b. Saluran yang lebih besar berada di luar mulut bayi, tidak dapat dijangkau oleh lidahnya;
- c. Lidah bayi berada di belakang mulutnya dan tidak menekan saluran yang lebih besar. Bayi di gambar 2 tidak melekat dengan baik. Dia "mengisap puting" dan tidak bisa menyusui dengan efektif

Tabel 3.1 Berbagai Posisi Menyusui

POSISI	KETERANGAN
Posisi menggendong (cradle) 	Posisi ini merupakan posisi yang paling umum digunakan
 Posisi menyilang (cross cradle)  Posisi menyilang untuk bayi kembar	Posisi ini berguna bagi: - bayi yang baru lahir dan bayi kecil dan lemah - bayi apapun dengan kesulitan melakukan posisi - bayi apapun dengan kesulitan melakukan pelekatan - bisa digunakan untuk bayi kembar

Posisi berbaring menyamping (side lying). 	Posisi ini cocok dan nyaman bagi ibu setelah melahirkan dan ini membantu ibu istirahat sambil menyusui. Ibu dan anak keduanya berbaring di sisi masing-masing dan berhadapan.
Posisi di bawah lengan (under arm)   Posisi di bawah lengan untuk bayi kembar	Ibu duduk dengan nyaman dengan bayinya di bawah lengannya. Badan bayi melewati sisi ibu dan kepalanya berada sejajar dengan payudara. Posisi ini sangat tepat diterapkan: - Setelah operasi Caesar - Ketika puting terasa sakit/nyeri - Untuk bayi kecil - Ketika menyusui anak kembar

BAB 4

KELAS ANTENATAL TERPADU KONSELING MENYUSUI

A. Pelaksanaan Kelas Antenatal terpadu Konseling Menyusui

Pertemuan kelas antenatal care terpadu oleh bidan dengan praktik konseling menyusui dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali pertemuan dengan jarak pertemuan setiap minggu sesuai kesepakatan fasilitator dengan peserta. Jumlah peserta dalam kelas minimal 10 orang dan maksimal 15 orang.

Materi pada pertemuan pertama membahas tentang Kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, keluhan umum saat hamil dan cara mengatasinya, apa saja yang perlu dilakukan ibu hamil dan pengaturan gizi termasuk pemberian tablet tambah darah untuk penanggulangan anemia) sesuai dengan modul dan Perawatan kehamilan (kesiapan psikologis menghadapi kehamilan, hubungan suami istri selama kehamilan, obat yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, tanda bahaya 12 kehamilan, dan P4K (perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi).

Pertemuan kedua membahas Persalinan (tanda-tanda persalinan, tanda bahaya persalinan dan proses persalinan). Pertemuan ketiga membahas tentang cara menyusui yang benar: a) Anatomi payudara dan cara produksi ASI b) Posisi dan pelekatan menyusui yang baik dan c) Cara pemerah ASI

dengan tangan, menyimpan ASI perah, dan memberikan ASI perah dengan cangkir. Pertemuan Keempat membahas tentang praktik menyusui yang direkomendasikan dan pertemuan Kelima membahas tentang menangani kesulitan cara pemberian ASI.

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar andragogi (pembelajaran orang dewasa) dengan pendekatan budaya sasak yaitu Bededeh, Bedengah yang artinya mengajarkan materi dengan menyelipkan lagu-lagu sasak untuk dinyanyikan agar lebih memahami isi dari materi sehingga nanti bisa diterapkan saat bedengah artinya saat mengasuh bayi dan merespon janin dalam kandungan. Bidan dalam melaksanakan tugas ini menerapkan sikap Genem yaitu memberikan perhatian dan respon positif pada setiap perubahan ibu hamil, baik saat di kelas maupun saat melakukan pemeriksaan ANC. Berikut lagu yang diajarkan pada ibu hamil yang mengikuti kelas antenatal terpadu praktik konseling menyusui agar bisa dinyanyikan saat menggendong bayinya dan untuk selalu mengingatkan tentang tehnik menyusui menggunakan lagu berbahasa Sasak (Lombok).

BEDEDE, MENYUSUQ

Semeton bini ...

Silaq pade berajah caren menyusiq

Arak telu ... arak telu care te menyusiq

Usahayang ampoq ne puas nyukupin nutrisin bebeak 2x

Caren menyusiqcaren menyusuk sak penembek

Iweb ebeakde ampoq bongkerne kance bongkorde

Bongkorne bongkorde sla mun bau beselanggha elek

galeng2x

Saq kedua.....sak kedua caren te menyusuq
Harus beseliwahan imen inaqne sambil tepanggong eleq
betekde

Saq ketelu tindok nyelili sambil menyusuq santai
Beselangah elek galeng laguk ingat betekde sik kanan
Ingat betekde,,,,,ingat betekde sik kanan sejjar kance
kentokne2x

Dendek de pade lupa lupak dende lupa lek pabidapo
Ampok selapuk potok,....potok susunde tame elek biweh
bebeak

Aampok nyangoq.....ampok nyango bebeak bedepet elek bawa
susun inakne

Dait e perhatian ampok sak ndeq arak suaren sak mecak
mecak

Sangkep bebeak ...sangkep bebeak ndekne kempes
Sak kendenghan ...sak kendenghan suaren sak bebelet
Ingat kentok ...ingat kentok ampok sak lurus

Lagu Ciptaan : Tim peneliti

Arransemen : Bobby Entertainment

B. Pendidikan Kesehatan Meningkatkan Keberhasilan ASI eksklusif

Meningkatkan pendidikan tentang ASI eksklusif selama pemeriksaan antenatal dapat membantu meningkatkan pengetahuan ibu sebelum melahirkan. Pendidikan selama antenatal tentang ASI eksklusif dapat dilakukan secara terus menerus / berkesinambungan berhubungan erat dengan intensi pemberian ASI eksklusif dengan arah dan kekuatan yang positif kuat [18]. Konseling ini dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok, dengan fokus pada manfaat ASI eksklusif, cara menyusui yang benar, dan dampak negatif dari susu formula[19]

Pendampingan selama antenatal meningkatkan niat dan motivasi mereka dalam memberikan ASI eksklusif setelah melahirkan. IMD meningkatkan interaksi ibu dan bayi baru lahir segera terjadi. Dengan IMD, ibu semakin percaya diri untuk tetap memberikan ASI-nya sehingga tidak merasa perlu untuk memberikan makanan/minuman apapun kepada bayi karena bayi bisa nyaman menempel pada payudara ibu atau tenang dalam pelukan ibu segera setelah lahir [20].

Kelas Antenatalcare Terintegrasi Konseling Menyusui Meningkatkan Keterampilan Kader, Ibu Hamil Tentang Asi Eksklusif Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Pendampingan dengan metode ceramah, diskusi, demonstrasi menggunakan boneka/alat peraga, konseling kit dan mendatangkan ibu menyusui untuk demonstrasi kegiatan praktek. Kelas antenatal terpadu konseling menyusui berhasil meningkatkan keterampilan kader 66,7% dan keterampilan ibu hamil sebesar 50%. Perawatan antenatal terpadu dan konseling menyusui telah menunjukkan perbedaan dalam peningkatan pengetahuan,

praktik menyusui eksklusif dan kesiapan untuk menyusui. [21]-[22].

Akses ke konseling menyusui terampil yang berkualitas (setidaknya enam kontak) penting selama kehamilan, segera setelah melahirkan, dan selama dua yang pertama tahun hidup bayi atau lebih. Edukasi dan bimbingan antisipatif tentang menyusui, bersama dengan informasi berbasis bukti tentang awal inisiasi dan menyusui lanjutan, mempertahankan ASI memasok, dan mengatasi tantangan umum, membantu mencapai hasil menyusui yang optimal. Semua rumah sakit harus dilengkapi dengan baik untuk memberikan ASI yang terampil konseling sebagai bagian dari perawatan berbasis bukti [27].

C. Kegiatan Dukungan Pada Antenatal

Dukungan menyusui antenatal dapat dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan yaitu: 1. Kegiatan kelompok 2. Kegiatan individu.

1. Kegiatan kelompok

Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin dengan membahas topik-topik yang berbeda. Satu kelompok dapat terdiri dari ibu hamil atau dengan pasangannya.

- a. Tentukan topik-topik penting untuk dibahas dalam kelompok. Beberapa topik mungkin saja perlu dibahas secara individu.
- b. Jelaskan manfaat menyusui, khususnya ASI Eksklusif.
- c. Kebanyakan ibu memutuskan bagaimana mereka akan menyusui bayi mereka jauh sebelum mereka memiliki anak, seringkali sebelum mereka hamil. Jika seorang ibu telah memutuskan untuk menggunakan pengganti ASI, dia mungkin tidak berubah pikiran. Tapi kita bisa

membantu ibu yang bimbang dan memberi kepercayaan pada orang lain yang berniat menyusui. kita dapat mendorong ibu untuk menyusui secara eksklusif, bukan parsial. Bicarakan tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan apa yang terjadi setelah melahirkan; menjelaskan tentang ASI pertama, dan praktik di rumah sakit, sehingga mereka tahu apa yang diharapkan.

- d. Berikan informasi sederhana yang relevan tentang cara menyusui, seperti menyusui secara responsif dan memposisikan bayi.
- e. Diskusikan pertanyaan ibu.
- f. Biarkan para ibu memutuskan apa yang ingin mereka ketahui lebih banyak seperti beberapa dari mereka mungkin khawatir tentang pengaruh menyusui terhadap bentuk payudara mereka. Mungkin akan membantu jika mereka membahas kekhawatiran ini bersama-sama.
- g. Kegiatan kelompok tidak mencakup pemberian informasi tentang cara menyiapkan susu formula.

2. Kegiatan Individu

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat personal, dihadiri ibu dan keluarganya saja.

- a. Tanyakan tentang pengalaman menyusui sebelumnya.
- b. Jika ibu berhasil menyusui, kemungkinan besar ia akan melakukannya lagi. Jika ibu mengalami kesulitan, atau jika bayi diberi susu formula, dengarkan ceritanya dan berempati dengannya. Beri ibu informasi yang relevan untuk membantu membangun kepercayaan dirinya dalam menyusui. Jelaskan bagaimana ibu berhasil

menyusui kali ini. Yakinkan ibu bahwa kita akan membantunya.

- c. Tanyakan apakah ibu memiliki pertanyaan atau kekhawatiran.
- d. Periksa payudaranya hanya jika ibu mengkhawatirkannya. Beri ibu umpan balik positif jika kita memeriksa payudaranya [19].

Berikut poin-poin Praktik pemberian ASI yang direkomendasikan untuk didiskusikan terkait praktik konseling

Tabel 4.1 Praktik Pembersihan ASI

Praktik pemberian ASI yang dianjurkan	Diskusi terkait praktik konseling yang mungkin dilakukan Catatan: pilih 2 sampai 3 poin yang paling relevan dengan situasi ibu dan/atau TAMBAHKAN poin-poin diskusi lain yang sesuai
IMD: (1) Segera lakukan kontak kulit antara ibu dan bayi segera setelah lahir	• Kontak kulit antara ibu dan bayi akan memberikan kehangatan pada bayi dan dapat membantu merangsang timbulnya ikatan atau kedekatan, dan membantu perkembangan otak bayi. • Kontak kulit akan membantu mengalirnya Kolostrum/ASI pertama.

	• Dalam jam-jam pertama mungkin tidak terlihat adanya ASI. Bagi beberapa ibu, hal ini bisa memakan waktu sampai satu atau dua hari hingga ASI-nya keluar. Adalah penting untuk terus mendekatkan bayi ke payudara untuk merangsang produksi ASI. • Kolostrum adalah ASI pertama yang kental berwarna kekuningan yang dapat melindungi anak dari penyakit.
IMD:(2) Biarkan bayi mencari puting dan menyusui sampai puas minimal satu jam pertama kelahiran	• Pastikan bahwa bayi melekat dengan baik. • ASI pertama ini disebut kolostrum. Kolostrum itu berwarna kekuningan dan mengandung antibodi yang dapat melindungi bayi. • Kolostrum memberikan zat antibodi pertama terhadap berbagai penyakit. • JANGAN berikan cairan lain selain ASI setelah bayi lahir

Catatan: Pemberian ASI penting dalam beberapa hari pertama	• Pemberian ASI yang sering sejak bayi lahir akan membantu bayi belajar menyusu dengan pelekatan yang baik dan membantu mencegah terjadinya pembengkakan payudara ibu dan komplikasi lain. • Dalam beberapa hari pertama, bayi mungkin menyusu hanya 2 atau 3 kali sehari. Jika bayi masih mengantuk di hari kedua, ibu bisa saja memerah kolostrumnya dan memberikannya kepada bayi dengan gelas. • Jangan berikan yang lain – seperti air putih, susu formula, makanan atau cairan lain kepada bayi yang baru lahir.
ASI Eksklusif (tidak ada makanan atau minuman lain) sejak usia 0 sampai 6 bulan	• Dalam enam bulan pertama bayi hanya membutuhkan ASI. • Jangan berikan apapun selain ASI (bahkan air putih sekalipun) kepada bayi selama enam bulan pertama.

	• ASI mengandung seluruh cairan yang dibutuhkan bayi, bahkan dalam cuaca yang panas. • Memberikan air putih dan cairan lain kepada bayi akan membuatnya kenyang sehingga ia jarang menyusu, dan berakibat produksi ASInya juga berkurang. • Air putih, cairan lain dan makanan untuk bayi usia dibawah enam bulan akan menyebabkan diare.
Sering menyusui bayi, siang dan malam	• Setelah beberapa hari pertama, kebanyakan bayi baru lahir ingin sering menyusu, 8 sampai 12 kali sehari. Pemberian ASI yang sering dilakukan akan membantu produksi ASI. • Begitu pemberian ASI sudah mantap, susui bayi 8 kali atau lebih, siang dan malam agar produksi susu ibu tetap banyak. Jika bayi bisa mengisap dengan baik, merasa puas dan berat badannya bertambah, maka

	jumlah pemberian ASI tidaklah penting. • Semakin sering bayi mengisap (dengan pelekatan yang baik) maka semakin banyak produksi ASI. • Pada situasi bencana, bila ibu merasa ASI berhenti/kurang karena stress, terus menyusui untuk memastikan produksi ASI tetap ada dan dapat mencukupi kebutuhan bayi
Menyusui ketika bayi meminta disusui	• Tangisan adalah tanda bayi itu lapar. • Tanda-tanda awal bayi ingin disusui: - Resah - Membuka mulut dan menggelengkan kepala - Menjulurkan lidah - Mengisap jari atau tangan
Posisi dan pelekatan yang baik	• 4 posisi menyusui yang baik: tubuh bayi harus lurus, dan menghadap ke payudara, bayi harus dekat ke ibu, dan ibu menopang seluruh tubuh bayi, bukan hanya menopang leher dan pundaknya.

	• 4 tanda pelekatan yang baik: mulut terbuka lebar, dagu menyentuh payudara ibu, areola terlihat lebih banyak diatas puting susu bukan di bawahnya, dan bibir bawah terbuka.
Teruskan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun atau lebih	• ASI memberikan cukup banyak energi dan gizi selama periode pemberian makanan tambahan dan membantu melindungi anak dari penyakit.
ASI ketika bayi atau ibu sakit	• Berikan ASI lebih sering sewaktu bayi sakit. Gizi dan perlindungan imunologi/kekebalan dari ASI sangat penting bagi bayi saat ibu atau bayi dalam keadaan sakit. • Pemberian ASI memberikan rasa nyaman bagi bayi yang sakit.
Ibu perlu makan dan minum untuk menghilangkan rasa lapar dan haus	• Tidak ada makanan atau diet khusus yang diperlukan untuk menghasilkan ASI yang berkualitas. • Produksi ASI tidak dipengaruhi oleh makanan ibu. • Tidak ada makanan yang dilarang.

	• Ibu perlu didorong untuk makan lebih banyak untuk menjaga kesehatan.
Hindari pemberian ASI/susu dengan Botol	• Makanan atau minuman harus diberikan dengan cangkir agar bayi tidak menjadi bingung puting serta kemungkinan terjadinya kontaminasi • Pada situasi bencana, dengan lingkungan sanitasi yang buruk, pemberian ASI/susu harus dilakukan dengan menggunakan cangkir untuk menurunkan risiko diare

D. Konseling Antenatal

Konseling antenatal dimulai dengan diskusi menggunakan pertanyaan terbuka seperti: "Apa yang ibu ketahui tentang menyusui?" atau "Bagaimana ibu berencana menyusui bayi Ibu?" Pertanyaan terbuka ini membuka peluang untuk:

1. Memuji ibu tersebut atas pengetahuannya tentang menyusui atau rencananya untuk menyusui;
2. Mendiskusikan hambatan apa pun yang mungkin dikhawatirkan ibu dalam menyusui;
3. Mendiskusikan masalah yang mungkin dialami ibu tersebut dengan menyusui di masa lalu.

4. Jika kita mengajukan pertanyaan seperti, "Apakah ibu akan menyusui?" Ibu itu mungkin menjawab tidak. Ini merupakan contoh pertanyaan tertutup yang dapat mempersulit kelanjutan diskusi.
5. Gunakan keterampilan konseling kita untuk melanjutkan diskusi.
6. Dengarkan ibu hamil mendiskusikan kekhawatiran dan kekhawatiran pribadinya tentang menyusui bayinya. Diskusi harus berlangsung dua arah, bukan seperti ceramah.
7. Jika jawaban ibu tersebut menyatakan bahwa ia sudah mengetahui banyak tentang ASI eksklusif, kita dapat memperkuat pengetahuannya. Kita tidak perlu memberikan informasi yang sudah ia ketahui.
8. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, diskusi ini sangat penting untuk membantu seorang ibu membangun kepercayaan dirinya untuk menyusui.

Atasi kekhawatiran yang umum terjadi selama kehamilan

1. Dorong dia untuk memberi tahu kita jika dia memiliki kekhawatiran atau keraguan tentang menyusui, jika dia berniat memberikan ASI campuran.
2. Periksa payudaranya hanya jika dia mengkhawatirkannya.
3. Dia mungkin khawatir tentang ukuran payudaranya atau bentuk putingnya.
4. Payudara tidak perlu diperiksa secara rutin jika dia tidak mengkhawatirkannya.
5. Bangun kepercayaan dirinya dan jelaskan kita akan membantunya.

6. Ingatkan dia, dengan dukungan, dia bisa mendapatkan pengalaman menyusui yang positif. Jelaskan jika dia membutuhkan bantuan, petugas kesehatan akan membantunya saat dia melahirkan.
7. Diskusi individu juga merupakan saat yang tepat untuk menentukan di mana seorang ibu mungkin membutuhkan konseling dan dukungan tambahan. Kita dapat mengidentifikasi ibu dengan kekhawatiran yang perlu dibahas secara individu. Bantu ibu berbicara tentang masalah yang mungkin memengaruhi rencana ibu tentang cara menyusui bayi mereka. Tawarkan untuk berbicara juga dengan anggota keluarga untuk membantu mereka mendukung ibu tersebut [19].

Pada saat konseling antenatal, Bidan perlu menjelaskan poin-poin penting yang perlu diingat:

1. Jelaskan pentingnya menyusui dan kolostrum. Jelaskan bahwa ASI pertama ibu, kolostrum, sudah ada sebelum bayi lahir.
2. Menjelaskan rekomendasi global yaitu: pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan pemberian ASI hingga dua tahun.
3. Yakinkan ibu dan keluarga bahwa ASI adalah satu-satunya yang dibutuhkan bayi selama enam bulan pertama.
4. Mendiskusikan apa yang terjadi setelah melahirkan. Jelaskan praktik rumah sakit sehingga mereka tahu apa yang diharapkan:
 - a. Kontak kulit-ke-kulit sesegera mungkin dan terus-menerus
 - b. Mulai menyusui segera setelah lahir
 - c. Rawat gabung

5. Berikan informasi sederhana yang relevan tentang cara menyusui.
6. Tunjukkan posisi dan pelekatan bayi menggunakan boneka bayi
7. Jelaskan pemberian ASI yang responsive dan tidak terbatas, yang dapat memastikan suplai ASI yang baik.
8. Dorong ibu untuk berbagi kekhawatiran, keraguan dan perasaan mereka. Ibu hamil dalam kelompok yang pernah menyusui sebelumnya dapat berbagi pengalaman.
9. Tanyakan kepada ibu apakah mereka memiliki masalah lain, atau apa yang ingin mereka ketahui lebih banyak.
10. Di beberapa komunitas ibu mungkin mengkhawatirkan citra tubuh setelah melahirkan. Ibu lain telah menyaksikan pengalaman menyusui yang sulit, jadi mereka mungkin memiliki pertanyaan tentang tantangan tersebut.
11. Sesi kelompok menyediakan ruang untuk membahas masalah tersebut Bersama-sama. Yakinkan Ibu hamil bahwa tenaga Kesehatan akan membantu mereka menyusui setelah bayinya lahir.
12. Dorong mereka untuk meminta bantuan setelah melahirkan, jika perlu. Sebelum ibu meninggalkan fasilitas tersebut, ibu harus memiliki informasi lebih lanjut dan sumber daya komunitas.
13. Penting untuk mendiskusikan jenis dukungan apa yang akan dimiliki ibu setelah melahirkan dan di rumah.
14. Dorong ibu untuk berbicara dengan penyedia layanan Kesehatan mereka tentang praktek persalinan saying ibu. Praktik tertentu dapat memengaruhi kontak awal dan menyusui.

15. Dorong ibu untuk:

- a. Memiliki pendamping selama persalinan yang dapat tinggal Bersama mereka setelah bayinya lahir
- b. Dukungan ini selama dan setelah persalinan dapat membantu ibu merasa lebih nyaman dan didukung.
- c. Diskusikan intervensi, seperti meredakan nyeri dan operasi sesar dengan penyedia perawatan mereka sebelum persalinan.
- d. Setelah sesi kelompok, perkenankan setiap ibu untuk berbicara dengan kita secara individu. Tanyakan tentang pengalaman menyusui sebelumnya, jika dia pernah memiliki bayi lain [27]

BAB 5

PENUTUP

Keberhasilan Pemberian ASI eksklusif pada bayi dipengaruhi oleh pengetahuan, ketrampilan dan kesiapan Ibu untuk menyusui. Kesiapan Ibu menyusui harus dilakukan semenjak kehamilan. Penelitian ini mengevaluasi keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada ibu hamil yang telah mengikuti Kelas Antenatal Terpadu Konseling Menyusui.

Masa antenatal merupakan masa yang penting untuk mendiskusikan rencana menyusui. Sebelum memberikan edukasi, penting untuk mengetahui rencana ibu dan mungkin pengalaman ibu sebelumnya. Persiapan menyusui saat antenatal seperti menarik-narik puting, mamakai pelindung payudara atau mengoleskan krim khusus tidak efektif memberikan dampak pada proses menyusuinya.

Terdapat pengaruh Antenatalcare terpadu konseling menyusui terhadap pengetahuan ibu hamil tentang pemberian ASI dengan $P\text{-value } 0.025 < 0.05$; RR 2,495. Terdapat pengaruh Antenatalcare terpadu konseling menyusui terhadap keterampilan menyusui pada ibu hamil dengan $P\text{-value } 0.005 < 0.05$; RR 0,504. Terdapat pengaruh Antenatalcare terpadu konseling menyusui terhadap kesiapan ibu menyusui dengan $P\text{-value } 0.007 < 0.05$; RR 0,797. Ada pengaruh Antenatalcare terpadu praktek konseling menyusui dan memberikan efek pengaruh positif sebesar 1,9 terhadap Inisiasi Menyusu Dini. Tidak ada pengaruh Antenatalcare terpadu konseling menyusui terhadap pemberian ASI. Ada pengaruh Antenatalcare terpadu praktek konseling menyusui dan

memberikan efek pengaruh positif sebesar 2,228 terhadap pemberian ASI eksklusif. Diharapkan penelitian ini dapat diterapkan dan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan Antenatalcare terpadu praktek konseling menyusui.

Kegiatan dukungan menyusui pada masa antenatal dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti kegiatan kelompok maupun kegiatan individu. Topik-topik dapat dipilih sesuai kebutuhan satu per satu sehingga ibu dapat memahami dengan baik seluruh isi topik yang sedang dibahas. Konseling merupakan kegiatan yang sifatnya individu dimana akan membahas kondisi masing-masing ibu sehingga mendapatkan solusi terbaik dan tepat. Penting bagi tenaga kesehatan untuk memahami berbagai topik yang penting untuk diberikan pada masa antenatal.

Konseling menyusui selama ANC dapat mendorong pemberian ASI dini, namun konseling tidak umum dilakukan. Walaupun cakupan K1-dan K4 melampaui target namun hanya seperlima bidan melakukan pelayanan ANC secara lengkap dan benar untuk komponen pelayanan 10 T. Antenatal terpadu dengan praktek konseling menyusui akan lebih bermanfaat dan mudah dipahami oleh ibu hamil sehingga nantinya dapat meningkatkan cakupan ASI eksklusif untuk menurunkan angka stunting

DAFTAR PUSTAKA

- M. D. D. Suja, E. M. Puspitaningrum, and V. A. Bata, "Tingkat pendidikan ibu dan keberhasilan ASI eksklusif di perkotaan indonesia: analisis data ifls 5: mother's education level and successful exclusive breastfeeding in urban indonesia: an analysis of ifls 5 data," *Jurnal Keperawatan Sumba (JKS)*, vol. 1, no. 2, pp. 71–79, 2023.
- S. Sumaifa and R. Risnawati, "Analisis Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Posisi Menyusui Yang Benar Di Puskesmas Pattallassang," *Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan*, vol. 1, no. 3, pp. 241–248, 2023.
- D. Handiani and D. Anggraeni, "Faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif," *Jurnal Ilmu Kesehatan Universitas Salakanagara*, vol. 6, no. 2, pp. 8–16, 2020.
- L. M. Sasube and C. A. Lombogia, "ASI EKSKLUSIF DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA," *UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO*, 2023.
- J. Kebidanan Vokasional, I. Y. Diniaty, R. Stikes, and N. Hasanuddin Makassar, "PENGARUH EDUKASI KONSELOR LAKTASI TERHADAP KEBERHASILAN MENYUSUI 3 BULAN PERTAMA DI PUSKESMAS BONTOMARANNU."
- J; R. A. Jurnal, Y. Setiawati, A. S. Umrah, and A. Pertiwi, "Konseling Asi Terhadap Peningkatan Pemberian ASI: Pendekatan Studi Pre-Eksperimen," *Universitas Muhammadiyah Tangerang*, vol. 8, no. 2, pp. 7–13, 2023.

- S. Emilda, F. Quدراتullah, R. Gustiani, M. Adiguna, P. S. Studi I Kebidanan, and S. Mitra Adiguna, "UPAYA MENINGKATKAN CAKUPAN ASI EKSklusIF MELALUI KONSELING MANAJEMEN LAKTASI DENGAN BOOKLET," *Communnity Development Journal*, vol. 5, no. 1, pp. 993–997, 2024.
- S. Emilda, F. Quدراتullah, and R. Gustiani, "UPAYA MENINGKATKAN CAKUPAN ASI EKSklusIF MELALUI KONSELING MANAJEMEN LAKTASI DENGAN BOOKLET," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 993–997, 2024.
- S. Sudarmi, B. I. Rumintang, N. N. A. Murni, and N. P. D. A. Anggraeni, "KELAS ANTENATALCARE TERINTEGRASI KONSELING MENYUSUI MENINGKATKAN KETERAMPILAN KADER, IBU HAMIL TENTANG ASI EKSklusIF SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SUNTING," *GEMAKES: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 3, pp. 359–368, 2024.
- K. Kesehatan et al., "PEDOMAN PELAYANAN ANTENATAL TERPADU EDISI KEDUA."
- E. Ketiga, PEDOMAN PELAYANAN ANTENATAL TERPADU.
- R. Mochtar, "Sinopsis Obstetri Fisiologi dan Patologi," Jakarta EGC, 2012.
- W. A. Hidayah, C. Cholifah, and R. Rosyidah, "Management of Maternity with Back Pain Discomfort at the Clinic," *Indonesian Journal of Innovation Studies*, vol. 11, pp. 10–21070, 2020.

- K. Kesehatan and R. Indonesia, "Kurikulum Pelatihan Konseling Menyusui (End User)," 2022.
- F. A. Wijaya, "ASI Eksklusif: nutrisi ideal untuk bayi 0-6 bulan," *Cermin Dunia Kedokteran*, vol. 46, no. 4, pp. 296–300, 2019.
- M. Sattu, *Pengetahuan Dasar Gizi Ibu Hamil*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- S. Mawaddah, *Keputusan Ibu dalam Memberikan ASI Eksklusif*. Penerbit NEM, 2022.
- S. Efendi, N. Sriyanah, A. S. Cahyani, S. Hikma, and K. Kiswati, "Pentingnya pemberian asi eksklusif untuk mencegah stunting pada anak," *Idea Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 02, pp. 107–111, 2021.
- 2022 Kementerian Kesehatan RI, "MODUL PELATIHAN KONSELING MENYUSUI (Enduser)," Jakarta.
- S. Nurbaya, H. Hamdiah, N. Laela, and R. Rosmawaty, "Pengaruh Leaflet Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Praktek Mahasiswa Kebidanan Dalam Upaya Pemberian ASI Eksklusif," *Jurnal Promotif Preventif*, vol. 5, no. 1, pp. 81–85, 2022.
- E. Oktapiani, R. A. Yolandia, and M. S. Mardiyah, "HUBUNGAN DUKUNGAN BIDAN, RIWAYAT KUNJUNGAN ANC, DAN PENGETAHUAN IBU DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA PRAKTEK MANDIRI BIDAN ELIS DESA KEPOSANG KEC. TOBOALI KAB. BANGKA SELATAN TAHUN 2023," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, vol. 2, no. 5, pp. 1566–1577, 2023.
- T. R. I. Astuti, "HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DAN DUKUNGAN BIDAN DENGAN PEMBERIAN ASI

EKSKLUSIF DI DESA HUTABARINGIN KECAMATAN
SIABU," 2022.

- I. Nidaa and E. N. Hadi, "Inisiasi menyusui dini (IMD) sebagai upaya awal pemberian ASI eksklusif: scoping review," *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, vol. 6, no. 2, pp. 58–67, 2022.
- Y. Ulfa, N. Maruyama, Y. Igarashi, and S. Horiuchi, "Early initiation of breastfeeding up to six months among mothers after cesarean section or vaginal birth: A scoping review," *Heliyon*, vol. 9, no. 6, 2023.
- M. J. Nasrullah, "Pentingnya inisiasi menyusui dini dan faktor yang mempengaruhinya," *Jurnal Medika Utama*, vol. 2, no. 02 Januari, pp. 626–630, 2021.
- S. Sudarmi et al., *Kelas Antenatal Care (ANC) Konseling Menyusui Berbasis Budaya Sasak*. CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- WHO, "GUIDELINE: COUNSELLING OF WOMEN TO IMPROVE BREASTFEEDING PRACTICES," 2018.

GLOSARIUM

- 10 T : Serangkaian pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janin.
- ANC : Antenatal Care
- Antenatalcare : pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan.
- ASI : Air susu ibu
- ASI eksklusif : pemberian air susu ibu (ASI) sebagai satu-satunya sumber nutrisi bagi bayi selama enam bulan pertama kehidupannya.
- BBLR : Bayi Berat Badan Lahir Rendah
- BTA : bakteri tahan asam
- DJJ : Denyut jantung janin
- EKG : Elektrokardiografi
- Fe : Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe (ferrum)
- FKRTL : Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindakan Lanjut
- FKTP : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
- GPA : Garavida, Paritas, Abortus
- HIV : Human immunodeficiency virus
- IMD : Inisiasi Menyusu Dini
- IMS : Infeksi Menular Seksual
- IMT : Indeks Massa Tubuh
- K1 : kunjungan pertama ibu hamil ke tenaga kesehatan
- K1 Akses : Pemeriksaan diluar trimester 1 atau usia kehamilan lebih dari 12 minggu
- K1 Murni : Pemeriksaan pada trimester 1
- K4 : Kontak minimal 4 kali
- K6 : Kunjungan keenam pemeriksaan antenatal care (ANC) yang dilakukan pada usia kehamilan 37–41 minggu.

KEK	: Kurang Energi Kronik
Kolostrum	: Cairan yang keluar pertama kali dari kelenjar payudara setelah persalinan
KtP	: Kekerasan Terhadap Perempuan
Leopold	: Pemeriksaan fisik medis yang dilakukan dengan cara meraba perut dan panggul ibu hamil untuk mengetahui posisi janin
LILA	: Lingkar Lengan Atas
Non Poned	: Non Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
P4K	: Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
PAP	: Pintu Atas Panggul
PONED	: Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
SC	: Sectio Caesarea
TB	: Tuberkulosis
Td	: Tetanus Dipteri
TFU	: Tinggi Fundus Uteri
UK	: Usia Kehamilan
UNICEF	: United Nations Children's Fund
USG	: Ultrasonografi
WHO	: World Health Organization

PROFIL PENULIS



Dr. Sudarmi.,SST.M.Biomed Lahir di Kuken-Sumbawa, 28 Desember 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu D-III Kebidanan pada Program Studi D-III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram, D-IV Bidan pendidik di Universitas Padjajaran tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Biomedik pada Universitas Udayana-Denpasar dan lulus tahun pada tahun 2012. Tahun 2020 menyelesaikan Pendidikan S3 pada Program Studi S3 Kedokteran Biomedik di Universitas Udayana-Denpasar. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 sebagai Bidan di Puskesmas Moyo Hilir, kemudian sebagai staf pengajar di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram sejak tahun 2003 s.d sekarang. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Mataram mengampu mata kuliah Komunikasi dan Konseling dalam praktek kebidanan, Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui dan Biologi Reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar,dan editor jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail sudarmi.ude2812@gmail.com

Motto: "Jika orang lain bisa, maka akupun harus bisa Berjuang terus dengan Bismillah"

PROFIL PENULIS



Baiq Iin Rumintang, S.ST., M.Keb. Lahir di Mataram, 31 Januari 1980. Pendidikan kebidanan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III di Akademi Kebidanan Depkes Mataram tahun 2001, Program Studi Diploma IV Bidan Pendidik, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus pada tahun 2013. Riwayat

pekerjaan diawali pada tahun 2001 sebagai Bidan tenaga kontrak di RSUD Provinsi NTB. Kemudian sejak akhir tahun 2002 sampai saat ini menjadi staf pengajar di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Nifas dan menyusui, Gizi dalam Kesehatan Reproduksi dan Pengembangan Kepribadian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dan narasumber. Penulis juga merupakan Konselor Menyusui dan Konselor Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA). Penulis aktif dalam organisasi Sukarelawan yaitu Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) menjabat sebagai Ketua AIMI Daerah NTB Periode 2019-2024 dan 2024-2029. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: baiqiinrumintang@gmail.com
Motto:

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat"

"Jika Kita Membantu Seorang Ibu untuk Menyusui pada Hakikatnya Kita Sudah Membantu Seluruh Keluarga"

PROFIL PENULIS



Ni Putu Dian Ayu Anggraeni, S.ST., M.Tr.Keb. lahir di Negara, 24 Agustus 1988. Jenjang pendidikan tinggi penulis diawali ketika menyelesaikan DIII Kebidanan di Poltekkes Depkes Semarang pada tahun 2009. Pada tahun 2010 penulis menyelesaikan pendidikan DIV Bidan Pendidik di Poltekkes Depkes Semarang. Penulis kembali menyelesaikan

pendidikan untuk memperoleh gelar Magister Terapan Kebidanan di Pascasarjana Magister Terapan Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang pada tahun 2019. Penulis merupakan dosen tetap pada Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram sejak tahun 2010 hingga sekarang. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Keterampilan Dasar Kebidanan, Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui dan Asuhan Kebidanan Homecare. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, narasumber, dan reviewer jurnal. Penulis juga aktif sebagai Pembina UKM Tari Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram serta mendukung beberapa program organisasi mahasiswa. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail niputudianayu@gmail.com

Motto: "Sharing is Caring, Caring is Love, and Loving is Amazing. Sharing Caring Loving to be Healthy."

PROFIL PENULIS



St. Halimatusyaadiah lahir di Mataram, 23 Mei 1980. Jenjang pendidikan tinggi penulis diawali ketika menyelesaikan D III Kebidanan di AKBID Depkes Mataram pada tahun 2001. Pada tahun 2004 penulis menyelesaikan pendidikan D IV Kebidanan Bidan pendidik di Universitas Padjadjaran Bandung. Penulis kembali melanjutkan 86 pendidikan untuk memperoleh gelar Magister Kesehatan

Masyarakat konsentrasi manajemen Kesehatan ibu dan anak di Universitas Diponegoro Semarang. Penulis merupakan dosen tetap pada Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram sejak tahun 2001 hingga sekarang. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas, Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui dan Kesehatan Masyarakat.

SINOPSIS BUKU

ASI eksklusif, yaitu pemberian air susu ibu (ASI) tanpa tambahan makanan atau minuman lain kepada bayi berusia 0-6 bulan, memiliki banyak manfaat yang signifikan bagi kesehatan bayi dan ibu. Keberhasilan dalam pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun manfaatnya jelas, cakupan pemberian ASI eksklusif masih rendah.

Keberhasilan pemberian ASI eksklusif sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan ibu, dukungan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi. Meningkatkan kesadaran akan manfaat ASI eksklusif serta menyediakan dukungan yang memadai bagi ibu adalah langkah penting

untuk mencapai target cakupan yang lebih tinggi di masa depan.

Peningkatan pengetahuan dan dukungan emosional, dapat dilakukan melalui konseling dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi ibu dalam proses menyusui, sehingga mendukung kesehatan bayi dan ibu secara keseluruhan. Konseling menyusui merupakan alat yang efektif untuk

meningkatkan angka pemberian ASI eksklusif di kalangan ibu-ibu baru.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa konseling laktasi efektif diberikan pada masa prenatal, Pelayanan konseling menyusui yang dilakukan selama antenatal terpadu memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil mengenai menyusui.

Konseling menyusui adalah bagian dari pelayanan antenatal terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi dan dukungan kepada ibu hamil mengenai teknik menyusui, manfaat ASI, serta cara mengatasi masalah yang mungkin timbul selama menyusui

ASI eksklusif, yaitu pemberian air susu ibu (ASI) tanpa tambahan makanan atau minuman lain kepada bayi berusia 0-6 bulan, memiliki banyak manfaat yang signifikan bagi kesehatan bayi dan ibu. Keberhasilan dalam pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun manfaatnya jelas, cakupan pemberian ASI eksklusif masih rendah.

Keberhasilan pemberian ASI eksklusif sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan ibu, dukungan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi. Meningkatkan kesadaran akan manfaat ASI eksklusif serta menyediakan dukungan yang memadai bagi ibu adalah langkah penting

untuk mencapai target cakupan yang lebih tinggi di masa depan. Peningkatan pengetahuan dan dukungan emosional, dapat dilakukan melalui konseling dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi ibu dalam proses menyusui, sehingga mendukung kesehatan bayi dan ibu secara keseluruhan. Konseling menyusui merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan angka pemberian ASI eksklusif di kalangan ibu-ibu baru.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa konseling laktasi efektif diberikan pada masa prenatal. Pelayanan konseling menyusui yang dilakukan selama antenatal terpadu memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil mengenai menyusui.

Konseling menyusui adalah bagian dari pelayanan antenatal terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi dan dukungan kepada ibu hamil mengenai teknik menyusui, manfaat ASI, serta cara mengatasi masalah yang mungkin timbul selama menyusui.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7097-58-3



9

786347

097583